
СЕМИНАР · 25–27 АВГУСТА 2026

Не просто накормить

Как организовать безопасное, достойное и вариативное питание людей с психическими нарушениями в условиях социального обслуживания

Чистяков Евгений Владимирович
Директор СПб ГАСУСОН «ДСО „Серафимовский“»

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ · МИНТРУД РОССИИ



ЧТО ВНУТРИ

Пять разделов, тридцать минут

1

Почему это важно

Числа, которые останавливают. Главный вопрос к залу.

2

Право и доказательства

Цепочка Конституция → 3185-1 → 442-ФЗ → ИППСУ. Четыре российские практики.

3

Как это сделать

Лестница моделей, два варианта без второй кухни, дисфагия, лекарства, совет жителей.

4

Внедрение

Пилот 90 дней, аутсорсинг, диалог с проверяющим, дорожная карта на 12 месяцев.

5

Закрытие

Что делать в понедельник. Десять выводов. Контакты.

2

01

Почему это важно

Числа, которые останавливают. Пять конфликтов в одном обеде.
Главный вопрос к залу.





СЦЕНА • 12:30 • ОБЕД

СОБИРАТЕЛЬНАЯ СИТУАЦИЯ

Пять конфликтов за одним столом

В типовом учреждении за один обед сталкиваются пять проблем. Каждая имеет решение. Но вместе они образуют систему.

- 1 Жительница М. хочет тишины. Шум столовой — для неё пытка.
- 2 Житель К. на клозапине. Родственники принесли два термоса кофе.
- 3 Житель Н. давится. Сигналы видны, но кто-то должен их заметить.
- 4 Житель П. на оланзапине. Сиделка отказывает во второй котлете.
- 5 Неговорящий житель Л. Не ясно, что он любит. Карты нет.

Доклад, раздел 5. Собирательный, не реальный случай.

ДОКАЗАТЕЛЬНАЯ БАЗА

Числа, которые останавливают

15–20 лет

умирают раньше люди с тяжёлыми психическими
расстройствами

Correll 2022, World Psychiatry

7×

выше смертность от пневмонии vs. популяция

Correll 2022, мета-анализ 135 исследований

74%

Каждая цифра имеет источник, каждый источник — дату проверки. Доклад, разделы 4, 9, 10, 16.

жителей ПНИ признаны недееспособными

данные Минтруда, 2024

22–70%

дисфагия у принимающих антипсихотики

Miarons Font 2017, систематический обзор

ВОПРОС К ЗАЛУ

Кто в вашем учреждении
в действительности выбирает,
что сегодня будет есть житель?

Он сам

реже всего

Сиделка

по привычке

Врач

по показаниям

Кухня

чаще всего

Контрактный
управляющий

по спецификации

Региональная
норма

чаще всего

Поднимите руку те, кто может ответить прямо сейчас. Спор начинается здесь.

02

Право и доказательства

Где написано, что житель ПНИ имеет право на выбор еды?
Четыре российские практики. Новый СанПиН — что меняется.



ПРАВОВАЯ ЦЕПОЧКА

Где написано, что у жителя ПНИ есть право на выбор еды

① ПРИНЦИП

Конституция РФ

ст. 7, 21 — достоинство
личности

② ЗАКОН

3185-1

ст. 43 (1) → ч. 2 и 4 ст. 37

③ УСЛУГА

442-ФЗ

ст. 9 (1) + ст. 24 (4) — питание
как соц.-бытовая услуга

④ ПРОГРАММА

ИППСУ

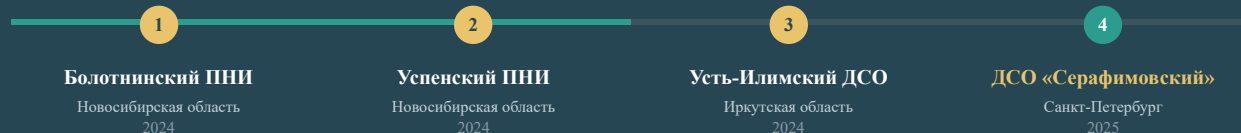
ст. 16 — учёт индивидуальных
потребностей

Выбор еды в стационаре — реализация конституционного достоинства. Не новшество, не прихоть, не эксперимент.

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО ПРАКТИКОЙ

Это уже делают в России

В 2024–2025 годах четыре учреждения публично внедрили вариативное меню. Это снимает с темы статус эксперимента.



«Жители с лёгкостью освоили новую систему. Страхи персонала не подтвердились».

— сообщение Успенского ПНИ, 13.08.2024

Источник: доклад, раздел 25; реестр SOURCE_REGISTRY.

НОРМАТИВНАЯ РАМКА

Новый СанПиН с 1 сентября 2026 года: что меняется

БЫЛО · до 01.09.2026

СанПиН 2.3/2.4.3590-20

- ХАССП — рекомендация
- Срок на раздаче: 2 часа
- Суточные пробы: 24 часа
- Аллергены: не обязательно объявлять



СТАЛО · с 01.09.2026

СанПиН 2.3/2.4.4282-26

- + ХАССП — **обязателен**
- + Срок на раздаче: 3 часа
- + Суточные пробы: **48 часов**
- + Аллергены: **обязательно объявлять**

Главное для нас: норма о трёхразовом питании и диетическом по показаниям сохраняется. Вариативность не запрещена. С 1 сентября — обновите положение, журналы, памятки.

КРАСНЫЕ ЛИНИИ

Чего нельзя делать без врача, учредителя, юриста

БЕЗ ВРАЧА

- назначать лечебное питание
- менять схему инсулина
- отменять препарат из-за «плохого аппетита»
- решать вопрос текстуры
- подменять назначение «опытом»

БЕЗ УЧРЕДИТЕЛЯ

- менять региональную норму
- выходить за пределы сметы
- менять раскладку
- «тихо» внедрять выбор
- согласовывать аутсорсинг

БЕЗ ЮРИСТА

- изменять контракт
- писать ТЗ на аутсорсинг
- оформлять отказ жителя
- работать с переданными
- согласовывать спецификацию

Правило спикера: в каждом сомнительном решении — на ком лежит ответственность? Ответ должен быть в приказе, фамилия, должность. Иначе ответственности нет.

Доклад, раздел 33 — «Ответственность директора: честная карта рисков без запугивания».

03

Как это сделать

Лестница моделей. Два варианта без второй кухни.
Дисфагия, лекарства, совет жителей.



СТУПЕНИ ВАРИАТИВНОСТИ

От мономеню к выбору: пять ступеней

Большинство домов ближайший год — на ступенях 1–2. Ступень 5 остаётся горизонтом.

СТУПЕНЬ 1	Цикличное меню по раскладке	минимум: 0 усилий
СТУПЕНЬ 2	Опрос предпочтений жителей	минимум: 1 неделя работы
СТУПЕНЬ 3	Выбор из 2 вариантов на завтрак и обед	пилот: 90 дней
СТУПЕНЬ 4	Совет жителей по питанию участвует в цикле меню	горизонт: 6 месяцев
СТУПЕНЬ 5	Своя кухня отделения, тренировка бытового решения	горизонт: год+

Доклад, раздел 8. «Лестница моделей» — критерии реального выбора и движения вверх.

ЧТО ЗНАЧИТ «НАКОРМИТЬ»

Шесть измерений одной тарелки

Накормить — это не только калории. Измеряйте по всем шести, тогда выбор становится видимым и честным.

ИЗМЕРЕНИЕ 1

Достаточность

Доля несъеденных порций

ИЗМЕРЕНИЕ 2

Безопасность

Сверка проб, текстур, бракераж

ИЗМЕРЕНИЕ 3

Удовольствие

Блюда-аутсайдеры по остаткам

ИЗМЕРЕНИЕ 4

Социальность

Есть ли разговор за столом

ИЗМЕРЕНИЕ 5

Самостоятельность

Доля жителей, проходящих линию сами

ИЗМЕРЕНИЕ 6

Выбор

Что ты сегодня выбрал?

Минимум по каждому измерению: один замер в неделю. Без замера выбора нет — есть только каша.

ТЕХНОЛОГИЯ ВАРИАТИВНОСТИ

Два варианта блюда: без второй кухни

1

Пара эквивалентов в раскладке

Гречка ↔ рис, курица ↔ рыба, яблоко ↔ груша. Уже есть в ваших таблицах замен.

2

Закупка — группами, а не монопозициями

«Крупы гарнирные: гречка, рис, пшено». Пропорции — по статистике выбора, корректируются раз в квартал.

3

Варка параллельно на одной плите

Два гастрорёмкости рядом, разные позиции. Без второго повара — в те же минуты.

4

Линия раздачи — два варианта визуально

Карточки с названием, подпись «А / Б». Стандартный вариант — всегда, для тех, кто не выбрал.

5

Журнал выбора + журнал замен

Кто выбрал что, что выдано вместо отказа. Два журнала — доказательство перед проверкой.

ТРИ МЕТРА РАЗДАТКИ

Точка раздачи: где выбор живёт или умирает

①

Видимость

Оба варианта видны жителю
за 3 секунды до выбора

②

Поток

Очередь без давления.
Два повара — параллельно

③

Помощь

Подача тем, кто не говорит.
Два варианта на подносе

④

Атмосфера

Тихо. Без команд. Без «почему
не ел?»

Два бесплатных замера, которые стоит сделать один раз и повторять ежеквартально:

Температура блюд на первом и последнем столе
падение $>10-15^{\circ}\text{C}$ — перестроить поток

Время на еду у самого медленного
если <15 мин — риск аспирации

Доклад, раздел 20. «Два замера, которые стоит сделать».

СКРЫТАЯ ЭПИДЕМИЯ

Дисфагия: что делать без логопеда

22–70% принимающих антипсихотики. Логопеда в учреждении нет. Что закрывает риск без него — пакет из четырёх элементов.

① РАСПОЗНАВАНИЕ

Шесть признаков, видимых без инструментов

кашель · «мокрый» голос · долгое жевание · еда за щекой · подтекание · повторные пневмонии

② ПОЗА И ТЕМП

90° — подбородок вниз — малые глотки

30 мин после еды без укладывания. Бесплатно.

③ ТЕКСТУРА ПО IDDSI

Шкала 8 уровней + тесты вилкой/наклоном

исследование: соответствие выросло 44→90% после обучения

④ ГОТОВНОСТЬ К ИНЦИДЕНТУ

2 обученных на посту в часы еды

алгоритм Геймлиха. Это часть пищевой безопасности, не «общая первая помощь».

Предел пакета называется прямо: он не лечит дисфагию, не заменяет инструментальную оценку, не отменяет врача. Делает другое: переводит организацию из состояния «не знаем, кто в риске» в состояние «знаем, наблюдаем, исполняем назначения».

ЛЕКАРСТВЕННО-ПИЩЕВЫЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

Пять правил, которые обязана знать кухня

Одна таблица на посту — бесплатная мера безопасности. Доклад, раздел 11.

№	ПАРА	СУТЬ	КЛАСС
1	Клозапин ↔ кофеин	Кофеин ↑ AUC клозапина на 19% (Hägg 2000). Отмена — падение на 37–47%.	установлено
2	Литий ↔ соль и вода	Резкие колебания в любую сторону — риск интоксикации. Стабильность.	мониторинг
3	ИМАО ↔ тирамин	Выдержанные сыры, копчёности, брынза, соевый соус — гипертонический криз.	установлено
4	Карбамазепин ↔ грейпфрут	AUC ↑ на 40% (Garg 1998). Грейпфрут исключить из закупки.	установлено
5	Алкоголь / энергетики	Нулевая терпимость. Серые зоны — энергетики при биполярном расстройстве.	рекомендация

Источники: Hägg 2000, Carrillo 1998, Cleveland Clinic, NHS SPS, RLSnet. Форма таблицы — приложение 21.

УЧАСТИЕ ЖИТЕЛЕЙ

Совет жителей: от объекта — к соавтору меню

Совет по питанию — это не собрание «для галочки». Это рабочий орган, который меняет меню.



Дегустации

новые блюда — до включения
в цикл



Сбор пожеланий

ящик, форма, личная беседа
сиделки



Участие в цикле

обсуждение пар эквивалентов,
сезонности



Доведение решений

протокол, публикация
на стенде

Кто в совете: 5–7 жителей, способных выразить мнение (речь, жест, карточка с фото) + диетсестра + старшая сиделка. Частота — ежемесячно. Протокол — один лист. Это не инициатива, это процедура.

УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ ИНСТРУМЕНТ

Панель 12 чисел: превращаем выбор в управление

Один лист — кварталный. Без панели выбора нет, есть только каша. Доклад, раздел 22.



Значения — иллюстративные. Цель — тренд по своим цифрам. Источник — раздел 22, приложение 35.

Аутсорсинг: что отдать, что нельзя

Если кухня — не своя. Вариативность, не вписанная в ТЗ, от аутсорсера не дождёшься.

МОЖНО ОТДАТЬ

- варка и выдача по ТЗ
- производство двух вариантов
- соблюдение ХАССП с 01.09.2026
- суточные пробы (под контролем)
- транспортировка, посуда

НЕЛЬЗЯ ОТДАТЬ

- бракераж готовой продукции (акт учреждения)
- список дисфагического риска
- текстурные назначения (врач)
- маршрут эскалации отказа от еды
- фотофиксация приёмки (152-ФЗ)

Восемь строк в ТЗ: группа позиций (не монопозиция) · пропорции с корректировкой раз в квартал · правило замены · характеристики текстур · формат приёмки · ответственный и форма акта · срок недопоставки · контроль линии в часы раздачи.

04

Внедрение

Пилот 90 дней. Диалог с проверяющим. Дорожная карта на 12 месяцев. Возражения — честные ответы.



ПЕРВЫЙ ШАГ

Пилот 90 дней: три месяца — одно отделение

Без новой сметы. Без новых ставок. Модель Новосибирской области — два варианта на завтрак и обед.

МЕСЯЦ 1

Замеры

- 7-дневный замер отходов
- опрос предпочтений
- фактический ночной интервал
- список группы риска
- фактические трудозатраты

МЕСЯЦ 2

Документы

- 12 документов комплекта
- обучение смены (IDDSI)
- приказы с фамилиями
- согласование с учредителем
- закупка групп

МЕСЯЦ 3

Пилот

- выбор из 2 вариантов на завтрак + обед
- 1 типовое отделение
- журнал выбора и замен
- панель 12 чисел
- разбор с командой

«Без новой сметы» не значит «без затрат»: полный переход на весь дом может потребовать оборудования и ставок — это публично назвал петербургский кейс (ДСО «Серафимовский»).

ДИАЛОГ С ПРОВЕРЯЮЩИМ

Что показать проверяющему: комплект из 12 документов

Не «второе меню», а систему. Проверяющий видит процедуру — и спор прекращается.

ОСНОВАНИЕ

- Положение о питании
- Меню с парами
- Согласование с учредителем

КЛИНИКА

- Лекарственно-пищевая таблица
- Список риска дисфагии
- Журнал отказов

ОПЕРАЦИОНКА

- Журнал заказа и замен
- Пищевые карты
- Приказы с фамилиями

УПРАВЛЕНИЕ

- Регламент совета
- Панель 12 чисел
- Письмо учредителю

Показывать папкой, не слайдом: «вот положение, вот приказ, вот журнал за 30 дней, вот согласование учредителя». Спор прекращается, когда проверяющий видит систему.

Доклад, раздел 51, 52. Карточка Q&A для стикера: 02_презентация/дополнения_18.08.2020.

ЧЕСТНЫЕ ОТВЕТЫ

Шесть возражений и честные ответы

«Это дорого»

Пилот — без новой сметы. Считайте по 7-дневному замеру отходов, а не по бумажке.

«У нас нет ставок»

На одном отделении — в те же руки. Полный переход — другая экономика, но это публично назвал петербургский кейс.

«Персонал против»

Успенский ПНИ: «страхи не подтвердились, жители с лёгкостью освоили». Пилот покажет — не теория.

«Жители не поймут»

Показ двух порций, карточки с фото, пищевая биография — способы объяснить без слов.

«Учредитель не разрешит»

Изменения через учредителя переживают проверки. Тихие — нет. Письмо — 10 вопросов, не ультиматум.

«Это не наше дело»

Еда — это первая линия защиты. Ст. 43 (1) 3185-1 — права пациентов психиатрического стационара.

Полный список — 14 возражений: доклад, раздел 37. На семинаре — раздаточный материал 14 с полными ответами.

ГОРИЗОНТ

Дорожная карта на 12 месяцев: от пилота к системе

Каждый квартал — самостоятельная ценность. Не надо ждать конца года, чтобы показать результат.

Q1 · МЕСЯЦЫ 1–3

Пилот

- 1 отделение
- 2 варианта
- 12 документов
- панель 12 чисел

Q2 · МЕСЯЦЫ 4–6

Тираж

- 3 отделения
- совет жителей
- согласование с учредителем
- обучение смен

Q3 · МЕСЯЦЫ 7–9

Система

- весь дом
- закупка группами
- ТЗ аутсорсера
- переход на СанПиН 4282-26

Q4 · МЕСЯЦЫ 10–12

Следующий кейс

- публичный отчёт
- вход в регистр
- помощь коллегам
- новый семинар 2027

Доклад, раздел 36. Каждый квартал заканчивается панелью 12 чисел, не отчётом наверх.

05

Заккрытие

Что делать в понедельник. Десять выводов.
Контакты и источники.



ЧТО ДЕЛАТЬ В ПОНЕДЕЛЬНИК

Девять шагов, которые можно начать завтра

- | | | |
|---------------------------------------|--------------------------------|---|
| 1 Экспресс-аудит стола за 10 мин | 2 Замерить ночной интервал | 3 Повесить лекарственно-пищевую таблицу |
| 4 Завести журнал отказов | 5 Опрос предпочтений жителей | 6 Написать учредителю 10 вопросов |
| 7 Назначить ответственного за питание | 8 Проверить выбор у постельных | 9 Открыть спецификацию аутсорсера |

Доклад, раздел 4.2. Время на каждый шаг — от 10 минут до одного дня.

ГЛАВНОЕ ЗА 45 МИНУТ

Десять выводов

1. Еда — юридически значимая зона, не бытовая
2. Выбор блюд законен — и уже делают в России
3. Главные риски стола — клинические, и они измеримы
4. Четыре лекарственно-пищевых правила — на пост
5. 74% недееспособны — и это не отменяет выбор
6. «Диабетический стол» — зона врача, не шаблона
7. Вариативность — это документы, не только блюда
8. Финансовая модель начинается с замера, не с обещания
9. Директор не отвечает за всё, но отвечает за систему
10. Пилот 90 дней реалистичен на 1 отделении

Доклад, раздел 4. Каждый вывод раскрыт в указанном разделе. Полный текст — в докладе.

СЛАЙД 30 · ДИСКУССИЯ 26.08 · 14:00–15:30

Шесть вопросов дискуссии «Организация питания: опыт реализации проектов»

Чистяков Е. В. (ДСО «Серафимовский») · Нурбаев Т. А. (ДСО «Тесовый берег»). Полные ответы — раздел 17.12 доклада.

ВОПРОС 1

Кто выбирает форму питания — проживающий или его «хозяин»?

ВОПРОС 2

Как формировать меню в условиях жёстких нормативно-правовых и финансовых ограничений?

ВОПРОС 3

Должно ли быть питание в социальных домах «лечебным»?

ВОПРОС 4

Как совместить «лечебное» и «вариативное», не ограничивая право на выбор?

ВОПРОС 5

Как соблюсти баланс выбора недееспособного и медицинских показаний?

ВОПРОС 6

Как совместить качество продуктов и нормирование цен?

Главный практический вывод: лечебное и вариативное не противоречат друг другу — они решают разные задачи. Учреждение реализует оба режима одновременно, разделив их документально (диета = назначение врача, основное меню = социально-бытовая услуга по ИППСУ).

СЕМИНАР · 25–27 АВГУСТА 2026

Спасибо.

Через год — десять публичных кейсов, не четыре. Методика отработана. Система учится на своих числах.

Чистяков Евгений Владимирович

директор СПб ГАСУСОН «ДСО „Серафимовский”»

pni9.ru · github.com/qlolp/seminar-variable-food-2026

«Если в вашем доме что-то из написанного не работает — это не отказ от темы, а данные. Напишите их в панель и измените метод».

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ · 2026 · МИНТРУД РОССИИ

